

# ICU 年次レポート ダイジェスト

## 2025年度

対象期間 2025年04月01日 ～ 2026年03月31日 にICU入室した **587例** | 作成 2026年10月

### 要旨

入室は**587例**、ICU死亡率は**3.6%**と6年で最も低い。重症度で補正した標準化死亡比（SMR）は**0.65**で、6年続けて信頼区間の上限が1を下回り、「重症度から予測されるより死亡が少ない」水準を保っている。

一方で、**再入室率が12.3%**と過去6年で最高になり、**院内死亡率は13.7%→16.6%**と上昇した。ICUを生きて退室した後に亡くなる患者が増えている。

病床は8床で、正午時点の在室は平均**7.1人**（利用率89%）、**満床の日が年間146日**あった。特定入院料の算定率は**74.9%**で、在室日数の約25%は管理料を算定できていない。

## 1. 今年度の全体像

ICU入室患者数

**587** 例

▲ 34例 前年度 553例

ICU死亡率

**3.6** %

▼ 1.1 pt 前年度 4.7%

院内死亡率

**16.6** %

▲ 2.9 pt 前年度 13.7%

標準化死亡比 SMR

**0.65**

▲ 0.07 前年度 0.57

再入室率

**12.3** %

▲ 2.9 pt 前年度 9.4%

人工呼吸実施率

**23.3** %

▼ 4.3 pt 前年度 27.7%

ICU在室日数（中央値）

**3.0** 日

6年間変わらず

在室患者数（正午時点の平均）

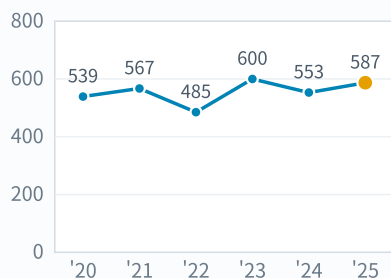
**7.1** 人

3～8人・8床の利用率89%

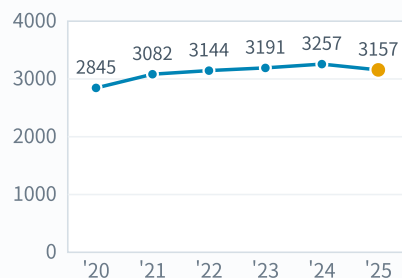
緑＝改善、赤＝悪化、灰＝良し悪しを判定しない指標。SMR＝院内死亡数 ÷ APACHE III による予測死亡数。

## 主要指標の年度推移（橙の点が2025年度）

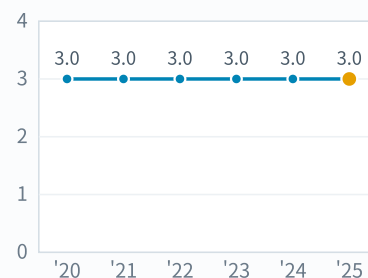
### 入室患者数 (例)



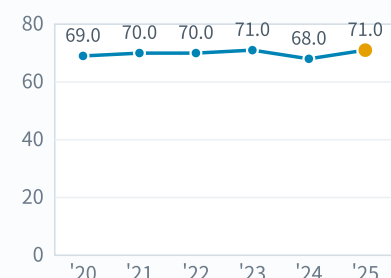
### 延べ在室日数 (日)



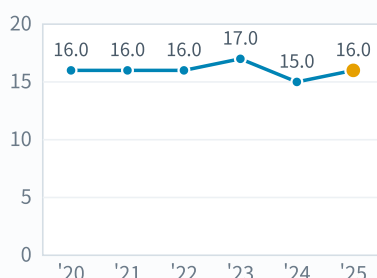
### ICU在室日数 中央値 (日)



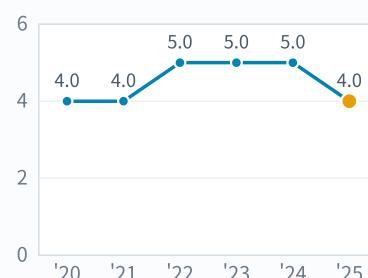
### 年齢 中央値 (歳)



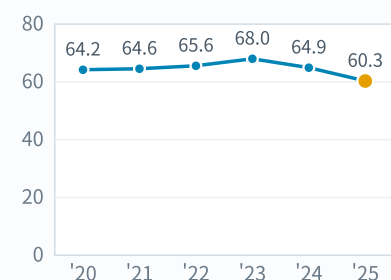
### APACHE II 中央値 (点)



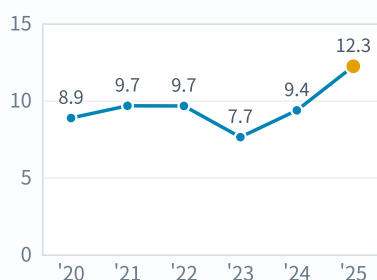
### SOFA 中央値 (点)



### 緊急入室 (%)



### 再入室 (%)



### 15日以上の長期滞在 (例)



縦軸は指標ごとに目盛りが違う。形の上下ではなく点に付いた数値を読む。

## 2. 押さえるべき3つの変化

### 01

#### 患者は増えたが、在室は伸びていない

入室は前年度比+34例の587例。延べ在室日数は3,257日→**3,157日**と**減少**し、在室日数の中央値は3.0日。15日以上 of 長期滞在は50例→**47例**。

意味するところ：同じ8床でより多くの患者を診ており、ベッドの回転が速くなっている。予定手術の割合が35.8%→**39.9%**に増えたことと整合する。

### 02

#### ICU死亡率は改善、院内死亡率は悪化

ICU死亡率は4.7%→**3.6%**、院内死亡率は13.7%→**16.6%**。

意味するところ：ICUを生きて退室した後に亡くなる患者が増えた。ICU内の成績だけを見ていると、この変化は見えない。

### 03

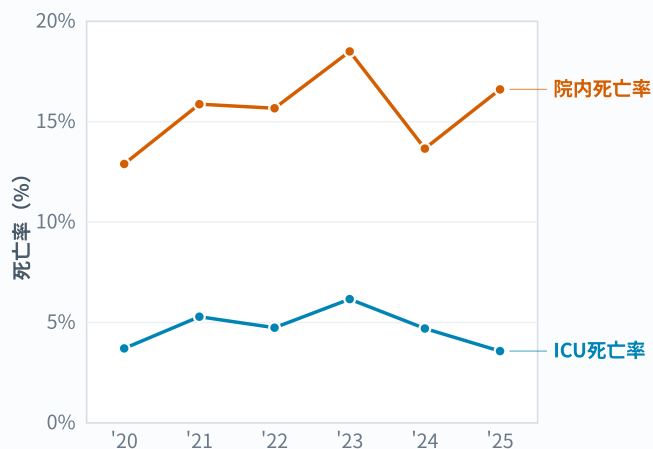
#### 再入室率が過去6年で最高

9.4%→**12.3%**。それまでの5年間は7.7～9.7%だった。

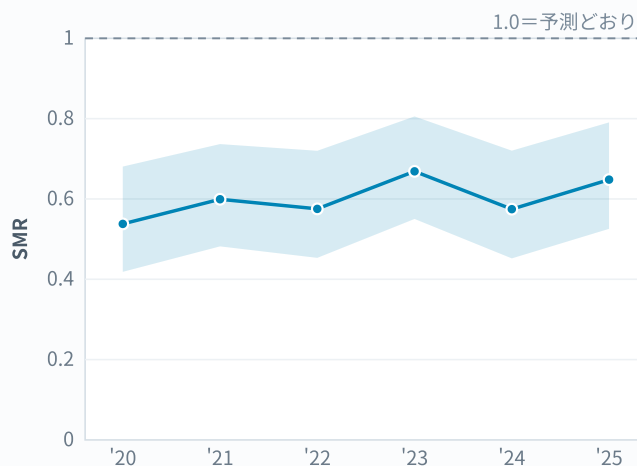
意味するところ：再入室は「早すぎる退室」の代表的な指標である。回転が速くなったこと（01）、退室後の死亡が増えたこと（02）と同じ方向を指しており、**同一の現象の別の側面である可能性がある**。

### 3. 診療の質は保たれている

死亡率の推移



SMR (APACHE III) 帯は95%信頼区間



**SMRは0.65 (95%信頼区間 0.53～0.79)。**6年間つねに信頼区間の上限が1を下回っている。重症な患者ほど死亡率は高くなるため、死亡率だけでは施設や年度を比べられない。重症度から予測される死亡数で割ったSMRが1を下回っていれば、予測より死亡が少ないことを意味する。

## 4. 病床と算定

病床利用率（8床）

**90.2 %**

▼ 3.2 pt 前年度 93.4%

満床の日数

**146 日**

正午時点の在室 3～8人

特定入院料の算定率

**74.9 %**

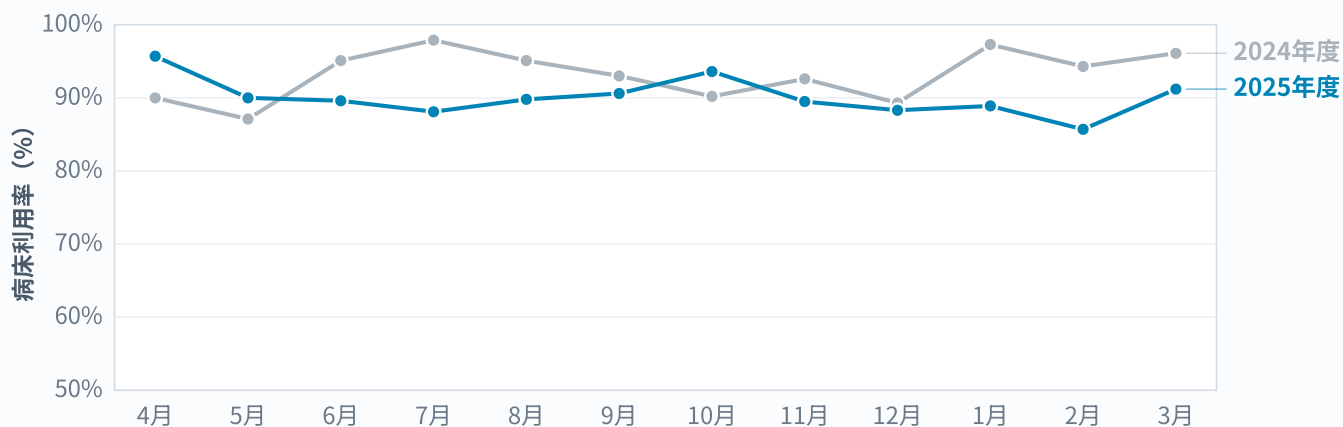
▼ 0.1 pt 前年度 75.0%

機会損失額（年間）

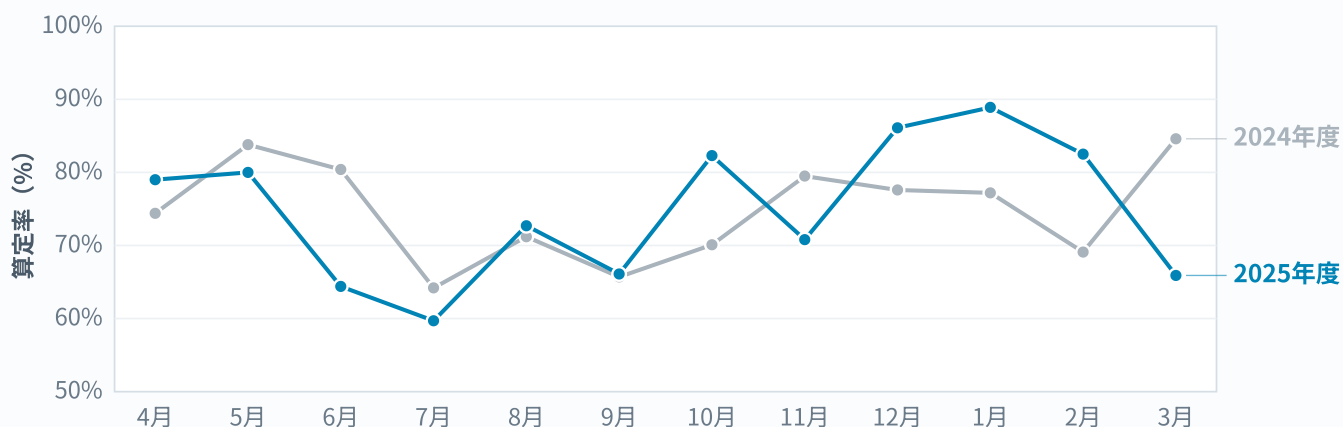
**7,059 万円**

▼ 338万円 前年度 7,397万円

月別 ICU病床利用率



月別 特定入院料の算定率



病床利用率・算定率・機会損失額は医事課の集計。月別の値は医事課のグラフから読み取った近似値（±1ポイント程度）で、年平均は医事課の表示値。

**在室日数の長い上位10%の患者が延べ在室日数の41%、上位20%で58%を占める。**15日以上長期滞在47例（入室の8%）だけで延べ在室日数の36%を使った。長期滞在患者を1人減らす効果は、短期入室を数人減らす効果より大きい。

急性血液浄化・ECMOによる算定上限の延長（14日→25日。施設基準はJIPADへの症例登録）で、今年度は18例・130日分、約1,513万円を算定した。

## 5. データの入力状況

| 項目                     | 2024年度 | 2025年度 |
|------------------------|--------|--------|
| 主病名（疾患群名）              | 97%    | 96%    |
| APACHE IIIスコア          | 100%   | 100%   |
| 退院時転帰                  | 99%    | 99%    |
| せん妄の有無                 | 100%   | 100%   |
| Charlson Risk Index    | 88%    | 96%    |
| Clinical Frailty Scale | 30%    | 93%    |
| 栄養開始までの時間              | 61%    | 53%    |
| 早期リハビリ開始日時             | 18%    | 20%    |
| 早期離床加算の算定有無            | 0%     | 100%   |

重症度・転帰など台帳の基本項目はほぼ全例そろっている。Clinical Frailty Scale と Charlson は再入力で今年度そろった（過去年度とは比べない）。リハビリ開始日時は記録が少なく、早期離床率はこの記録がある例だけで算出している。PT介入欄は2024年7月で運用を終えた。

## 付録：主要数値一覧

| 指標                 | 2024年度  | 2025年度  |
|--------------------|---------|---------|
| 入室患者数              | 553 例   | 587 例   |
| 延べ在室日数             | 3,257 日 | 3,157 日 |
| ICU在室日数（中央値）       | 3.0 日   | 3.0 日   |
| 予定手術の割合            | 35.8%   | 39.9%   |
| 緊急入室の割合            | 64.9%   | 60.3%   |
| ICU死亡率             | 4.7%    | 3.6%    |
| 院内死亡率              | 13.7%   | 16.6%   |
| 標準化死亡比（APACHE III） | 0.57    | 0.65    |
| 再入室率               | 9.4%    | 12.3%   |
| 人工呼吸実施率            | 27.7%   | 23.3%   |
| HFNC利用率            | 28.0%   | 21.6%   |
| せん妄発生率             | 42.5%   | 35.4%   |
| 15日以上 of 長期滞在      | 50 例    | 47 例    |
| 早期経腸栄養率（48時間以内）    | 68.5%   | 55.6%   |
| 早期離床率（48時間以内）      | 52.6%   | 53.2%   |
| 在室患者数（正午時点の平均）     | —       | 7.1 人   |
| 病床利用率（8床・医事課）      | 93.4%   | 90.2%   |

| 指標             | 2024年度   | 2025年度   |
|----------------|----------|----------|
| 特定入院料の算定率（医事課） | 75.0%    | 74.9%    |
| 機会損失額（医事課）     | 7,397 万円 | 7,059 万円 |

早期経腸栄養率・早期離床率はICU滞在48時間超かつ18歳以上が対象。詳細な定義と分母は年次レポート詳細版を参照。

データ出典：20260904ICU症例統合全データ.xlsx / ExJIPAD\_20260910102157.csv（医事課集計を除く）。詳細は「聖路加ICU  
2025年度 年次レポート詳細版」を参照。  
聖路加国際病院 集中治療科 ICU年次レポート 2025年度 ダイジェスト  
院内資料。患者個人を特定する情報は含まれていません。